



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : عيبر علي الدين ابراهيم عيسى

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : الزاوية الحمراء العنوان : //

رقم البطاقة : 27008170100207 رقم التليفون : 01124273610 تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 17-08-1970 المهنة : حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : ----- التوقيع : -----

الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : ----- التوقيع : -----

الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : ----- التوقيع : -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----

خطة العلاج : -----

المستشفى : ----- قسم : -----

جهة العلاج : ----- نفقات : -----

ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عبير علي الدين ابراهيم عيسى National ID: 27008170100207	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الى Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



عبيد
على الدين ابراهيم عيسى
١٤ ش توفيق زيدان - القصيرين
الزاوية الحمراء - القاهرة

٢٧٠٠٨١٧٠١٠٠٢٠٧
LR9160617

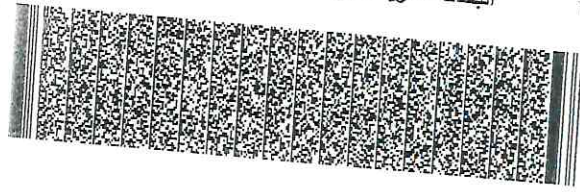
٠١١٢٢٧٣٦١٠
٠١١٥٣٥٠٥٠٢٠



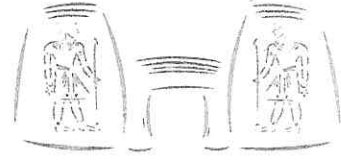
٢٠٢٦/٠٤ ٢٧٠٠٨١٧٠١٠٠٢٠٧
حاصلة على دبلوم تجارة

أنثى مسلمة

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٤/٠٨



الكرنك للأشعة والتحاليل Karnak Scan & Lab



Patient Name: Mrs. Abeer Aley Eldeen Ibrahim

Date: 19/08/ 2026

Ref. By: Prof. Dr. Ali Mafouz

BILATERAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASONOGRAPHY REVEALED:-

CLINICAL SUMMARY:

- 1.5 months history of right breast lump sensation. Old history of bilateral breast reduction. Positive family history (aunt: mother's side)

FINDINGS: -

- The right breast shows mild upper central skin thickening (4.6 mm).
- Otherwise, Normal skin thickness and contour with normal nipple/ areola complex and subcutaneous tissues.
- Heterogeneous fibro-glandular element on both sides.
- **The right breast at the upper central region shows dense mas lesion with irregular outlines and speculations. In ultrasound, it is seen along 12 O'clock orientation, about 10 cm from the nipple (site of complaint/ palpable lump), seen as ill-defined heterogeneous hypoechoic mass lesion with increased internal vascularity, measuring about 3.6x2.8x3.2 cm in maximum dimensions. It is seen connected to a retro areolar dilated duct (4 mm) with turbid contents.**
- No suspicious solid or cystic lesions noted on the left side.
- No significant retro areolar ducts on either side.
- No suspicious micro-calcifications seen.
- Bilateral axillary reactive lymph nodes with preserved fatty hila, yet one of them on the right axilla with preserved fatty hilum shows focal cortical thickness (4.2 mm)
- **Left upper arm: shows a superficial large isoechoic oval lesion with regular outlines, measuring about 10x5x4 cm, with no internal vascularity detected, likely a lipoma.**

OPINION: -.

- Right breast upper central malignant looking mass lesion with possible intra ductal extension as well as one indeterminate axillary lymph node as described (BIRADS 4), for trucut needle biopsy.
- Unremarkable left sono-mammography (BIRADS 1).

Dr. Mariana Fikry, Msc

83 Ain Shams St. - Cairo

24 993 133 - 24 923 702

012 22 353 572 - 010 34 414 830 - 011 53 388 880

010 29 461 757



٨٣ شارع عين شمس - أمام فرع أورنج - القاهرة

٢٤٩٢٣٧٠٢ - ٢٤٩٩٣١٣٣

٠١١٥٣٣٨٨٨٨٠ - ٠١٠٣٤٤١٤٨٣٠ - ٠١٢٢٢٣٥٣٥٧٢

٠١٠٢٩٤٦١٧٥٧

karnakscanrec@gmail.com

Mammogram

(DOCTYPE:MAMMOGRAM)

www.karnakscan.com

الكرنك للأشعة والتحاليل Karnak Scan & Lab



Patient Name: Mrs. Abeer Aleey Eldeen Ibrahim

Date: 19/08/ 2026

Ref. By: Prof. Dr. Ali Mafouz

BILATERAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASONOGRAPHY **REVEALED:-**

CLINICAL SUMMARY:

- 1.5 months history of right breast lump sensation. Old history of bilateral breast reduction. Positive family history (aunt: mother's side)

FINDINGS:-

- The right breast shows mild upper central skin thickening (4.6 mm).
- Otherwise, Normal skin thickness and contour with normal nipple/ areola complex and subcutaneous tissues.
- Heterogeneous fibro-glandular element on both sides.
- The right breast at the upper central region shows dense mas lesion with irregular outlines and speculations. In ultrasound, it is seen along 12 O'clock orientation, about 10 cm from the nipple (site of complaint/ palpable lump), seen as ill-defined heterogeneous hypoechoic mass lesion with increased internal vascularity, measuring about 3.6x2.8x3.2 cm in maximum dimensions. It is seen connected to a retro areolar dilated duct (4 mm) with turbid contents.
- No suspicious solid or cystic lesions noted on the left side.
- No significant retro areolar ducts on either side.
- No suspicious micro-calcifications seen.
- Bilateral axillary reactive lymph nodes with preserved fatty hila, yet one of them on the right axilla with preserved fatty hilum shows focal cortical thickness (4.2 mm)
- Left upper arm: shows a superficial large isoechoic oval lesion with regular outlines, measuring about 10x5x4 cm, with no internal vascularity detected, likely a lipoma.

OPINION:-

- Right breast upper central malignant looking mass lesion with possible intra ductal extension as well as one indeterminate axillary lymph node as described (BIRADS 4), for trucut needle biopsy.
- Unremarkable left sono-mammography (BIRADS 1).

Dr. Mariana Tifody MSc

83 Ain Shams St. - Cairo

24 993 133 - 24 923 702

012 22 353 572 - 010 34 414 830 - 011 53 388 880

010 29 461 757

<https://www.facebook.com/Karnakscan>



karnakscanrec@gmail.com

www.karnakscan.com



شارع عين شمس - أمام فرع أورنج - القاهرة

٢٤٩٢٣٧٠٢ - ٢٤٩٩٣١٣٣

٠١١٥٣٣٨٨٨٨٠ - ٠١٠٣٤٤١٤٨٣ - ٠١٢٢٢٣٥٣٥٧٢

٠١٠٢٩٤٦١٧٥٧

Patient Name	عبير على الدين ابراهيم	Case No.	361874
Sex/Age	Female 56 Y	Patient No.	26574
Registered Date	01/9/2026 10:15:54 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	24/9/2026 11:00:12 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	01/10/2026 10:36:14 AM	Pathology No.	2817/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 4).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 1/09/2026, cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

Four greyish white tissue cores, ranging in size between 1.5 cm & 2.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- **Histologic type:** Invasive duct carcinoma.
- **Histologic grade:** 3 (differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2).
- **DCIS:** Absent.
- **Microcalcification:** Present.
- **Angioinvasion:** Absent.
- **Perineural invasion:** Absent.
- **Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** Moderate.

Results:

- * IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 15% of tumor cells (score 6/8).
- Her2: Moderate complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+).
- Ki67%: 35%.
- SISH: Not amplified with polysomy (Copy #5.6, ratio 1.3).
- (repat SISH on specimen is advised)

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:
- **Invasive duct carcinoma, Grade 2.**
IPT:

Patient Name	عبر علي الدين ابراهيم	Case No.	361874
Sex/Age	Female 56 Y	Patient No.	26574
Registered Date	01/9/2026 10:15:54 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	24/9/2026 11:00:12 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	01/10/2026 10:36:14 AM	Pathology No.	2817/26

- ER: Positive (score 8/8).
 - PR: Positive (score 6/8).
 - Her2: Equivocal (score 2+).
 - Ki67%: 35%.
 - SISH: Not amplified with polysomy (Copy #5.6, ratio 1.3).
- (repat SISH on specimen is advised).

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Prof. Dr. Maha Guimei, MD, PhD.

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.